

TEMA 4.18 • DERMATOLOGÍA

Enfermedades Ampollares

PERFIL EUNACOM 6.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Manifestaciones Cutáneas de las Conectivopatías (Lupus y Dermatomiositis)

El espectro reumatológico inmunitario acarrea un profundo impacto como diana de asedio perimetral biológico en la piel. Existen marcadores dermatológicos directos patognomónicos en el examen físico para identificar el cruzamiento de estas letales enfermedades autoinmunes.

1. Lupus Cutáneo (Manifestaciones Focales Modulables)

El embate de anticuerpos reacciona crónicamente a cruzamientos con la radiación de luz, presentando estigmas estáticos: - **Lupus Cutáneo Subagudo y Discoide (Crónico):** Aparece como sólidas placas eritematosas costrosas descamativas encastradas asediando predominantemente zonas altísimamente **fotoexpuestas directas crónicas**. - **Riesgo Estético Permanente:** Particularmente el fenotipo "Discoide" es feroz destructivo y al retroceder asienta e irrumpe degenerando permanentemente provocando Cicatriz Atrófica perimetral cruzada. Cuando estos discos atacan e irrumpen la anatomía capilar cebácea cabelluda (Ej. La ceja o cuero craneal) exterminan para siempre la matriz dejando una estela irreversible estéril de **Alopecia Definitiva**. (Su freno en agudo inicial exige potentes *Corticoides Tópicos frotados directos fuertes en las placas activas*).

2. Lupus Eritematoso Sistémico (LES Crítico)

Emerge la patología cruzada reumatológica madre letal multiorgánica. - **El Estigma Patognomónico (El Rash Malar / La "Mariposa Lúpica"):** Asienta de un brochazo violento simétrico el enrojecimiento perimetral y rubicundez en placa de eritema que reviste como las alas abiertas de una mariposa todo el contorno de ambos **Pómulos y puente central de la Nariz**. - **Regla Semiológica de Oro Diferencial (LES vs Rosácea inflamatoria):** - La mariposa lúpica de manera milimétricamente pasmosa **Respeta Férrea y Nítidamente al Surco Nasogeniano** (sin invadir la piel limitante labial). - La clínica sistémica desenmascara paralela a la placa al lupus basal: El paciente manifiesta la triada cruzada inflamatoria paralela reumatológica (**Artralgias generales agudas duras, Daño órgano general renal cruzado por Glomerulonefritis, cansancio vital o leucopenia, más acentuada Fotosensibilidad**).

3. Dermatomiositis (El Asedio Cutáneo-Muscular Miopático)

Corresponde a la inflamación miopática profunda cruzada letal muscular dolorosa debilizante crónica inmune base; es tan letal o cruzada a la piel que su prefijo indica primero lo cutáneo antes que la destrucción general celular. Debuta paralelamente arrojando 3 Marcadores y Signos visualizados crónicos patognomónicos: 1. **Las**

Pápulas o Signo de Gottron: Reacción hipertrófica placa plana paralela con descamación pápulo eritematosa sobre relieve y nudos oseas limitantes de cruas estiradas crónicas **Ubicadas sobre las prominencias de los Nudillos (Metacarpofalángicas) e Interfalángicas del dorso de las Manos firmemente expuestas**. 2. **El Rash Heliotropo Ocular:** Se dibuja como una máscara simétrica de color y edematizada con mancha cruzando pigmento de tez **Rojo-Lila o Violáceo edematoso recubriendo en relieve cruzando sobre los Párpados Superiores ojos simétricos**. (Atención EUNACOM: Diferenciarlo netamente cruzado anamnesicamente de una puramente asintomática *Dermatitis Contacto Alérgica por Maquillaje cosmético ciego*. Si al edema lila sumamos debilidad franca proximal muscular letal cansante es indubitable y dictatorial la dermatomiositis). 3. **El Signo del Manto (Rash en Mantón / Signo Chal Estola o de la 'V'):** Placa extendida eritematosa inflamatoria de piel expuesta diseminantes como caída rocosa cruda afectando desde la nuca posterior, extendiendo a **Los hombros, la espalda superior cruzando la forma de una esclavina estola cruda y el pliegue profundo del escote delantero en cuello V roja masiva**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la diferencia clave entre el penfigoide ampollar y el pénfigo vulgar?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades Ampollares. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En el penfigoide ampollar las ampollas son tensas y el signo de Nikolsky es negativo.
- En el pénfigo vulgar las ampollas son flácidas y el signo de Nikolsky es positivo.
- El penfigoide tiene anticuerpos contra la lámina basal y el pénfigo contra los desmosomas.
- El pénfigo vulgar afecta mucosas orales frecuentemente y tiene mayor mortalidad que el penfigoide.
- El signo de Nikolsky positivo indica que la presión sobre piel sana produce desprendimiento epidérmico.
- La epidermolísis bullosa es genética congénita con ampollas desde el nacimiento ante mínimos traumas.
- Tanto el penfigoide como el pénfigo vulgar se tratan con corticoides orales como primera línea.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES AMPOLLARES)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la diferencia clave entre el penfigoide ampollar y el pénfigo vulgar?

- A)** El penfigoide afecta mucosas y el pénfigo solo la piel sin compromiso de mucosas
- B)** El penfigoide tiene ampollas tensas con Nikolsky negativo y el pénfigo flácidas con Nikolsky positivo
- C)** El penfigoide es más mortal que el pénfigo por afectación de órganos internos
- D)** El penfigoide se trata con antivirales y el pénfigo con corticoides sistémicos
- E)** El penfigoide es genético congénito y el pénfigo es adquirido autoinmune

PREGUNTA 2

¿Qué significa un signo de Nikolsky positivo?

- A)** Que las ampollas al presionarlas se convierten en vesículas más pequeñas
- B)** Que al presionar la piel aparentemente sana adyacente se desprende la epidermis
- C)** Que las ampollas tienen contenido purulento en vez de seroso transparente
- D)** Que el paciente tiene dolor intenso al presionar suavemente las lesiones
- E)** Que al raspar las lesiones se produce un sangrado puntiforme característico

PREGUNTA 3

¿Cuál es la característica principal de la epidermólisis bullosa?

- A)** Es una enfermedad autoinmune que se desarrolla en adultos mayores de cincuenta años
- B)** Es una enfermedad genética congénita con ampollas desde el nacimiento ante mínimos traumatismos
- C)** Es causada por el virus del herpes y produce ampollas en brotes intermitentes
- D)** Produce anticuerpos específicos contra la colágena tipo cuatro de la membrana basal
- E)** Se trata con inmunosupresores potentes desde el diagnóstico para controlar la enfermedad

RESUMEN: ENFERMEDADES AMPOLLARES

Las enfermedades ampollares autoinmunes incluyen tres condiciones importantes. El penfigoide ampollar es la más frecuente y se produce por anticuerpos contra la lámina basal de la piel. Las ampollas son tensas porque se forman en la unión dermoepidérmica, el signo de Nikolsky es negativo porque la piel perilesional no se desprende con la presión, y se trata con corticoides orales. El pénfigo vulgar es más grave y se produce por anticuerpos contra los desmosomas de unión entre queratinocitos. Las ampollas son flácidas porque se forman dentro de la epidermis, el signo de Nikolsky es positivo porque la epidermis perilesional se desprende fácilmente con la presión, tiene afectación de mucosas orales frecuente, y también se trata con corticoides orales pero con mayor riesgo de mortalidad. La epidermólisis bullosa es genética y no autoinmune, se presenta desde el nacimiento con ampollas que aparecen ante mínimos traumatismos, y se llama coloquialmente enfermedad de la piel de mariposa. Requiere manejo multidisciplinario de por vida.